

Guia para o Registro dos Indicadores de Desempenho da Atenção Primária à Saúde (APS)



SAÚDE

2023



MISSÃO

“Promover saúde e bem-estar para as pessoas.”



VISÃO

“Ser uma instituição ágil e inovadora, atenta as necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão de saúde pública no Brasil.”

VALORES



Orgulho e Paixão

Transparência

Empatia e Cuidado

Eficiência e Inovação

Sustentabilidade e Governança



SECRETÁRIO DA SAÚDE

Tânia Maria Eberhardt

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Jocelita Cardozo Colagrande

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Marlene Bonow Oliveira

DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE

Fabiana Fernandes de Almeida

DIRETORIA TÉCNICA

Amanda Bertolo Merki

GERÊNCIA DE DISTRITO SANITÁRIO

Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann – Distrito Centro

Luiza Helena Cardoso dos Santos – Distrito Norte

Jaqueline Fornari – Distrito Sul

GERÊNCIA DE ENFERMAGEM E GESTÃO ASSISTENCIAL

Vanessa Cardoso Pacheco

GERÊNCIA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA

Christine Bohm da Costa

COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO ASSISTENCIAL

Maristela Mello de Aguiar

ELABORAÇÃO/COLABORAÇÃO

Evaristo Cristóbal Iglesias Aleman – Médico

Flávia Favaretto – Agente Administrativo

Kerolin Daniele Schatzmann – Agente Administrativo

Scheyla Fonseca Martins – Enfermeira

LISTA DE QUADRO

Quadro 01 – Classificação CID-10/CIAP-2 para o encerramento do pré-natal	11
Quadro 02 – Código de Procedimento – Tabela Sigtap	11
Quadro 03 – Código de Procedimento – Tabela Sigtap	12
Quadro 04 – Esquemas Vacinais	16
Quadro 05 – Classificação CID-10/CIAP-2 para Doenças Hipertensivas	20
Quadro 06 – Classificação CID-10/CIAP-2 para Diabetes Mellitus	21

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

APS: Atenção Primária à Saúde

CBO: Classificação Brasileira de Ocupações

CID-10: Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde

CIAP-2: Classificação Internacional de Atenção Primária – Segunda Edição

CNS: Cartão Nacional de Saúde

CPF: Cadastro de Pessoa Física

DM: Diabetes Mellitus

DPP: Data Provável do Parto

DTP: Vacina Tríplice Bacteriana

DUM: Data da Última Menstruação

eSF: Equipe de Saúde da Família

eAP: Equipe de Atenção Primária

HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica

HIV: Vírus da Imunodeficiência Humana

INE: Identificador Nacional de Equipe

PA: Pressão Arterial

SIGTAP: Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

VDRL: *Venereal Disease Research Laboratory* (Estudo Laboratorial de Doenças Venéreas)

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	07
INDICADOR 1 – Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 12ª semana de gestação	09
INDICADOR 2 – Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV	11
INDICADOR 3 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado na Atenção Primária à Saúde	14
INDICADOR 4 - Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na Atenção Primária à Saúde.	15
INDICADOR 5 – Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas nas Unidades da Atenção Primária à Saúde contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por <i>Haemophilus Influenzae</i> tipo B e Poliomielite Inativada	16
INDICADOR 6 – Proporção de pessoas com hipertensão arterial, com consulta e pressão arterial aferida no semestre	18
INDICADOR 7 – Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre	21
REFERÊNCIAS	24

INTRODUÇÃO

Considerando a **Portaria GM/MS nº 2.979, de 12 de novembro de 2019**, que institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 06/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

Considerando que no seu Art. 9º esta Portaria dispõe que o financiamento federal de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) será constituído por:

- I – Capitação ponderada;
- II – Pagamento por desempenho; e
- III – Incentivo para ações estratégicas.

Considerando a **Portaria GM/MS nº 102, de 20 de janeiro de 2022**, que altera a Portaria GM/MS nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho, no âmbito do Programa Previne Brasil.

Considerando que no seu "Art. 1º esta Portaria dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho previsto na Seção III, do Título II, da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, institui os indicadores de monitoramento e custeio para os anos de 2020, 2021 e 2022 e estabelece as **ações prioritárias** para definição dos **indicadores do pagamento por desempenho**", são elas:

- I – Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª (primeira) até a 12ª (décima segunda) semana de gestação;
- II – Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV;
- III – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado;
- IV – Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS;
- V – Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por *Haemophilus Influenzae* tipo b e Poliomielite inativada;
- VI – Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre; e
- VII – Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.

Sendo as informações obrigatórias para validação destes 7 (sete) Indicadores de Desempenho, relacionadas a correta identificação do usuário com registro de:

- ✓ Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Cartão Nacional da Saúde (CNS) válidos;
- ✓ Data de Nascimento;
- ✓ Campo "sexo" preenchido;
- ✓ Os registros somente serão enviados se foram concluídos, dentro do mês de competência;

✓ Tipo de atendimento.

Para a validação dos Indicadores de Desempenho o usuário deve estar vinculado ao Indicador Nacional de Equipe (INE) das equipes eSF e eAP homologadas/válidas.

1. Consulta agendada programada/cuidado continuado; ou
2. Consulta agendada; ou
3. Escuta inicial/Orientação; ou
4. Consulta no dia; ou
5. Atendimento de Urgência.

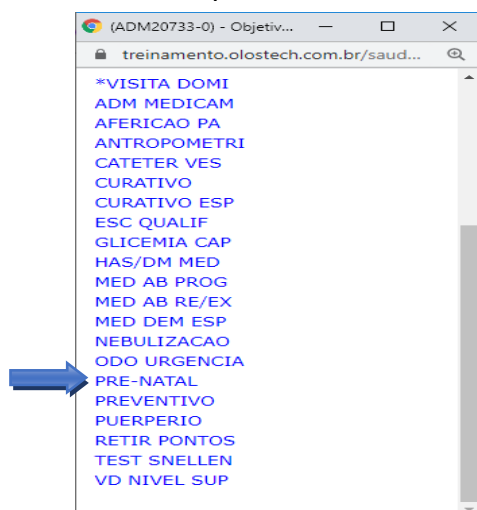
A **consulta agendada programada/cuidado continuado** deve ser usada nas consultas programadas, direcionadas para os acompanhamentos de gestantes, puericulturas, pessoas com doenças crônicas (HAS, DM), etc.

INDICADOR 1 – Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 12ª semana de gestação.

Recomendações específicas para o indicador 1:

- ✓ Registrar de forma individualizada o “problema/condição avaliada” com códigos CID-10 ou CIAP-2 correspondentes à gravidez, dessa forma, o módulo de acompanhamento do pré-natal já estará habilitado no atendimento individual SIG-SaúdeTech;
- ✓ CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) considerada para o atendimento do pré-natal: Médico (2251, 2252, 2253, 2231), Enfermeiro (2235);
- ✓ A gestante será contabilizada no quadrimestre da “finalização da gestação”;
- ✓ A gestante entre data da última menstruação (DUM) e data provável do parto (DPP) que apresentar CID-10/CIAP-2 de aborto/perda fetal é desconsiderada do quantitativo de gestantes;
- ✓ Meta pactuada para este indicador é de 45%.

Passo 01: Recepcionar a usuária utilizando o objetivo “Pré-natal”



Passo 02: Preencher/clicar procedimentos e condição clínica avaliada

Pré-Consulta/Aferições

Pré-Consulta não Realizada

Ocorrências em Saúde Avaliação/Resultados Cons. Alimentar

Atendimento Compartilhado

Dados Clínicos Permanentes

Índices/Gráficos

Perímetro Cefálico	Curvas de Crescimento				IMC entre 20 anos e 60 anos	Glicemia	P.A.
	Peso/Altura	Peso/Idade	Altura/Idade	IMC/Idade			
0 a 5 anos	0 a 2 anos 2 a 5 anos	0 a 5 anos 5 a 10 anos	0 a 5 anos 5 a 19 anos	0 a 5 anos 5 a 19 anos	IMC	Glicemia	P.A.

Evolução

Evolução Confidencial

Procedimentos

030101010 - Consulta Pre-Natal

Hipótese Diagnóstica

Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP)

Problema/Condição Avaliada

☒ PRE-NATAL ☐ SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA ☐ HIPERTENSAO ARTERIAL

☐ PUERPERIO (ATE 42 DIAS) ☐ PUERICULTURA ☐ DIABETES

Doenças Transmissíveis

☐ TUBERCULOSE ☐ HANSENIASE

Rastreamento

☐ CANCER DO COLO DO UTERO ☐ CANCER DE MAMA

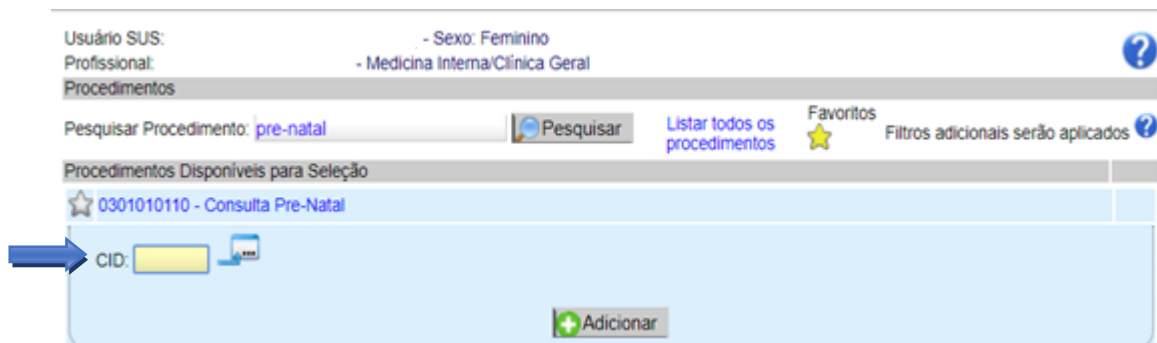
CID10

Não informado

Notificação

Passo 03: Preencher a Classificação Internacional de Doenças (CID-10)

Para esse indicador podem ser utilizados códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) Capítulo XV: Gravidez, Parto e Puerpério (O00-O99), sendo o agrupamento O00-O18 gravidez que termina em aborto e Capítulo XXI: Fatores que influenciam o Estado de Saúde e o Contato com os Serviços de Saúde (Z32-Z36)



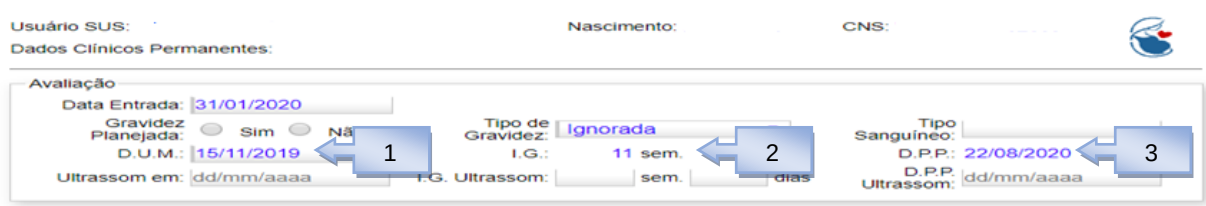
Passo 04: Preencher/Clicar em

- 1) Procedimento correto;
- 2) CID correto;
- 3) Condição avaliada;
- 4) Opção “gestante” marcada com “sim”
- 5) Inserir dados do pré-natal



Passo 05: Consultório Informatizado (Atendimento Médico/Enfermeiro) → Inserir as Informações da Gestação

Lembrando que o Indicador de Desempenho considera gestantes que iniciam o pré-natal com até 12 semanas de gestação. Assim, com o registro obrigatório da Data da Última Menstruação¹ (DUM), o Sistema calcula a Idade Gestacional² e a Data Provável do Parto³ (DPP) automaticamente.



A consulta de pré-natal **DEVE** ser **encerrada** até o 42º dia após o parto. Para o encerramento do pré-natal DEVE ser utilizado CID-10/CIAP-2 conforme **quadro 01**.

Quadro 01 – CID-10/CIAP-2 para o encerramento do pré-natal

Profissional	CID-10/CIAP-2	Descrição
Médico	O02, O03, O05, O06 O04; O42, O45; O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69; O70, O71, O73, O75.0, O75.1, O75.4, O75.5, O75.6, O75.7, O75.8, O75.9; O80; O81, O82, O83, O84;	Gravidez que termina em aborto; Aborto por razões médicas e legais; Complicações do trabalho de parto e do parto de nascido vivo; Complicações do trabalho de parto e do parto de natimorto; Parto único espontâneo;
	Z30.3 Z37.0, Z37.1, Z37.2, Z37.3, Z37.4, Z37.5, Z37.6, Z37.7, Z37.9 Z38 Z39	Parto; Nascimento único, nativo; Nascimento único, natimorto; Nascimento não especificado; Resultado do parto; Assistência e exame pós-natal; Extração menstrual.
Enfermeiro	W82	Aborto espontâneo
	W83	Aborto provocado
	W90	Parto sem complicações de nascido vivo
	W91	Parto sem complicações de natimorto
	W92	Parto com complicações de nascido vivo
	W93	Parto com complicações de natimorto

Fonte: Classificação Internacional de Atenção Primária – Segunda Edição (CIAP-2), Classificação Internacional de Doenças (CID-10)

INDICADOR 2 – Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.

Recomendações específicas para o indicador 2:

- ✓ O indicador é válido com sorologia avaliada ou teste rápido realizado para HIV e Sífilis na APS durante o pré-natal;
- ✓ Meta pactuada para este indicador é de 60%.

Quadro 02 – Código de Procedimento – Tabela Sigtap

SIGTAP	Descrição de Teste Rápido de Sífilis e HIV
02.14.01.004-0	Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou pai/parceiro
02.14.01.005-8	Teste rápido para detecção de infecção pelo HIV
02.14.01.007-4	Teste rápido para sífilis
02.14.01.008-2	Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro

Quadro 03 – Código de Procedimento – Tabela Sigtap

SIGTAP	Descrição de Sorologias avaliadas
02.02.03.111-0	Teste não treponêmico para detecção de sífilis
02.02.03.111-0	Teste não treponêmico para detecção de sífilis em gestantes
02.02.03.030-0	Pesquisa de anticorpos anti-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)

Importante:

- Avaliação da Sorologia (Sífilis e HIV) podem ser realizados por profissionais médicos (CBO 2251, 2252, 2253, 2231) e enfermeiros (CBO 2235);
- Realização do teste rápido (Sífilis e HIV) podem ser realizados por profissionais médicos (CBO 2251, 2252, 2253, 2231), enfermeiros (CBO 2235) e técnicos de enfermagem (sob supervisão do enfermeiro) que estejam atuando em qualquer estabelecimento da Atenção Primária, desde que o registro seja realizado no SIG-Saúde Tech;
- Avaliação dos exames de Sífilis e HIV: Atendimento realizado por médico (CBO 2251, 2252, 2253, 2231); enfermeiro (CBO 2235);
- Teste Rápido dos exames de Sífilis e HIV: procedimento realizado por médico (CBO 2251, 2252, 2253, 2231); enfermeiro (CBO 2235); técnicos de enfermagem.

Passo 01: Recepcionar a usuária com objetivo “Pré-Natal” → Incluir Procedimento

Evolução Confidencial Clique para Editar

Procedimentos 10

0301010110 Consulta Pré-Natal

Hipótese Diagnóstica Notificação

Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP)

W03 - HEMORRAGIA ANTES DO PARTO

Problema/Condição Avaliada

☒ PRE-NATAL ☐ SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA ☐ HIPERTENSAO ARTERIAL ☐ OBESIDADE ☐ ASMA ☐ TABAGISMO ☐ USUARIO DE OUTRAS DROGAS	☐ PUERPERIO (ATE 42 DIAS) ☐ PUERICULTURA ☐ DIABETES ☐ DESNUTRICAO ☐ DPOC ☐ USUARIO DE ALCOOL ☐ SAUDE MENTAL	Doenças Transmissíveis ☐ TUBERCULOSE ☐ HANSENIASE ☐ DENGUE ☐ DST	Rastreamento ☐ CANCER DO COLO DO UTERO ☐ CANCER DE MAMA ☐ RISCO CARDIOVASCULAR
---	--	---	---

Passo 02: Adicionar o procedimento de Teste Rápido (Sífilis, HIV)

Procedimentos

Pesquisar Procedimento: [Listar todos os procedimentos](#) [Favoritos](#) [Filtros adicionais serão aplicados](#)

Procedimentos Disponíveis para Seleção

- ★ 0214010040 - Teste Rapido Para Hiv Na Gestante Ou Pai/Parceiro, Deteccao De
- ★ 0214010058 - Teste Rapido Para Infeccao Pelo Hiv, Deteccao De
- ★ 0214010074 - Teste Rapido Para Sífilis
- ★ 0214010082 - Teste Rapido Para Sífilis Na Gestante Ou Pai/Parceiro

Procedimentos Selecionados

0214010040 - Teste Rapido Para Hiv Na Gestante Ou Pai/Parceiro, Deteccao De

CID-10: -

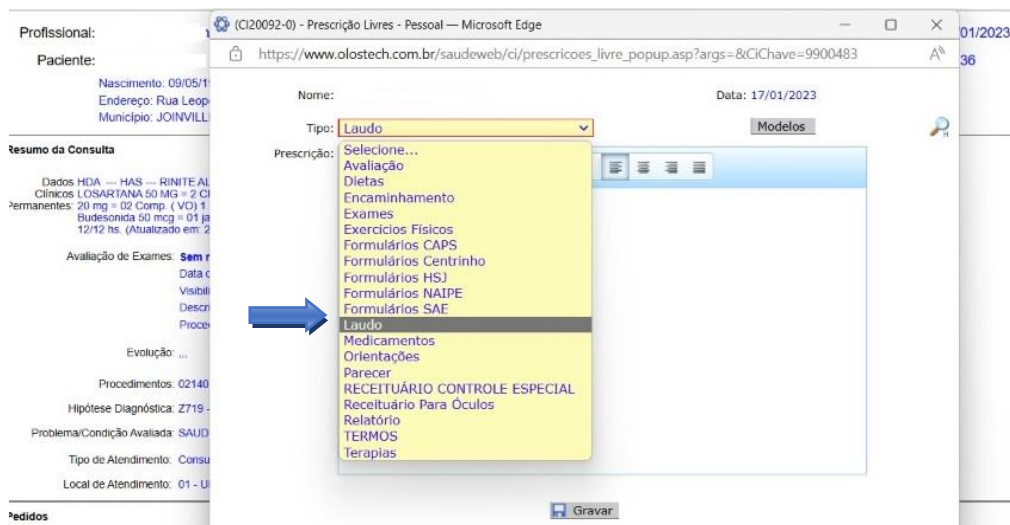
Passo 03: Na tela da consulta, evoluir a consulta e verificar informações conforme a seguir: Procedimentos e CIAP-2 (enfermeiros) ou CID-10 (médicos)

Passo 04: Inserir o laudo do Teste Rápido de VDRL no SIG-Saúde Tech “Avaliação de Exames” (e não apenas na evolução)

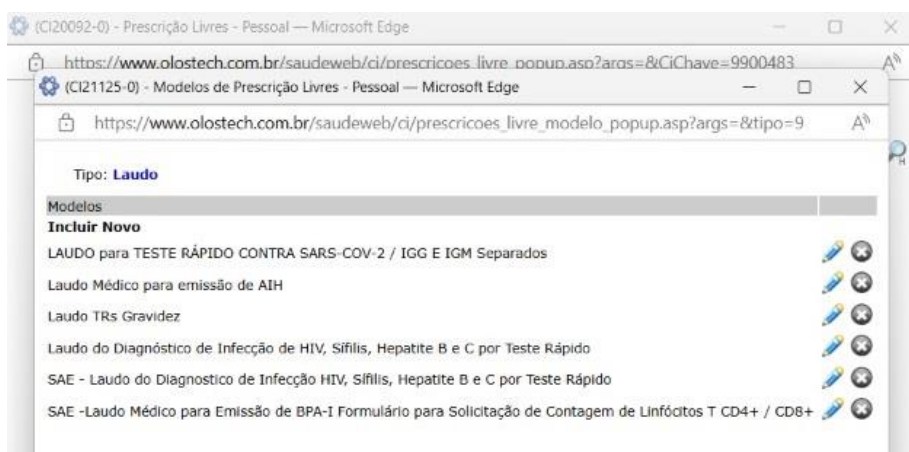
Passo 05: Selecionar o exame → preencher a descrição com a avaliação/resultado do exame → clicar em gravar → concluir

Passo 06: Emitir a “Prescrição de Laudo” dos testes rápidos na aba “Prescrições Livres”

1) Selecionar “Laudo”



2) Selecionar “Modelos”



INDICADOR 3 – Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado na Atenção Primária à Saúde.

Recomendações específicas para o Indicador 3:

- ✓ Gestantes identificadas que tenham registro de no mínimo um (1) atendimento odontológico individual realizado por cirurgião dentista no período entre o início e fim da gestação;
- ✓ Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) considerada válida para o atendimento odontológico individual: Cirurgião dentista (2232-08);
- ✓ No atendimento individual preencher o campo “GESTANTE” com **SIM**;
- ✓ O registro clínico dos procedimentos odontológicos durante a consulta da gestante, pode ser usado qualquer procedimento validado pela Tabela SIGTAP;
- ✓ Meta pactuada para este indicador é de 60%.

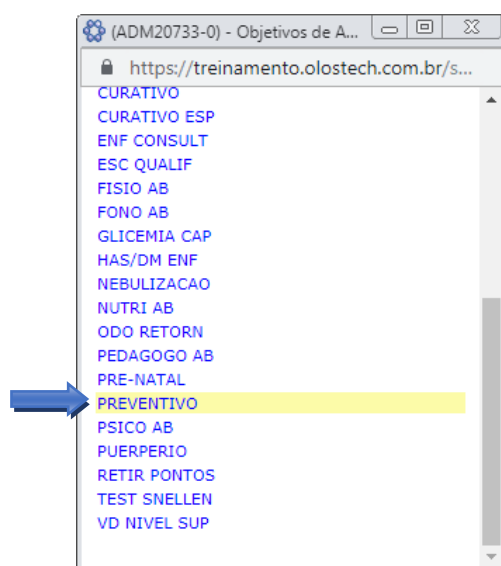
Avaliação de Exames	
Nenhuma avaliação registrada	
Evolução	
Clique para Editar	
Procedimentos	CID-10
0301010030 - Consulta De Profissionais De Nivel Superior Na Atencao Primaria (Exceto Medico)	
Hipótese Diagnóstica	Não informado
Tipo de Atendimento:	Selecione... Origem da consulta: Recepcionado
Tipo de Consulta:	Selecione...
Local de Atendimento:	01 - Ubs
Necessidades especiais:	☐ Sim
Gestante:	☒ Sim
Vigilância em Saúde Bucal:	
☐ Abscesso dento alveolar ☐ Alteração em tecidos moles ☐ Dor de dente ☐ Fendas ou fissuras lábio palatais ☐ Fluorose dentária moderada ou severa ☐ Traumatismo dento alveolar ☐ Não se aplica (na)	

INDICADOR 4 – Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na Atenção Primária à Saúde.

Recomendações específicas para o Indicador 4:

- ✓ Mede a proporção de mulheres com idade entre 25 e 64 anos atendidas na Atenção Primária que realizaram ao menos uma coleta de citopatológico do colo de útero no intervalo de 3 anos;
- ✓ Código de Procedimento SIGTAP usado para validar o indicador: 02.01.02.003-3 – “Coleta de Material p/ exame citopatológico do colo uterino”;
- ✓ Clicar em Problema/condição avaliada rastreamento câncer de colo de útero;
- ✓ A meta atualmente pactuada para este indicador é de 40%.

Passo 01: Recepcionar a usuária utilizando o objetivo “Preventivo”



Passo 02: Incluir o Procedimento 02.01.02.003-3 – “Coleta de Material p/ exame citopatológico do colo uterino”

INDICADOR 5 – Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas nas Unidades da Atenção Primária à Saúde contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por *Haemophilus Influenzae* tipo B e Poliomielite Inativada.

Recomendações específicas para o Indicador 5:

- ✓ Mensurar o nível de proteção da população infantil contra as doenças imunopreveníveis citadas, mediante o cumprimento do esquema básico de vacinação de penta e pólio no primeiro ano de vida;
- ✓ Cálculo do indicador: Considera-se denominador, o número de crianças cadastradas e vinculadas pelo Identificador Nacional de Equipes (INE) validados que completaram 12 meses de idade no quadrimestre avaliado;
- ✓ Meta pactuada para este indicador é de 95%;
- ✓ É preconizado o esquema completo com as 3 doses de Pentavalente e 3 doses de Poliomielite Inativada (VIP), considerando os seguintes esquemas vacinais:

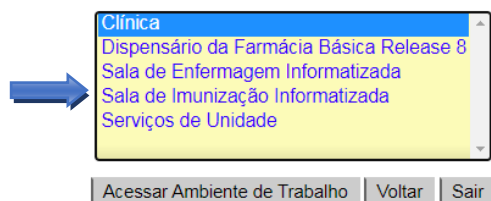
Quadro 04 – Combinações de esquemas vacinais que validam o Indicador 5

Cenário	Esquemas vacinais
Primeiro Cenário	2ª dose de Pentavalente + 1 dose de Poliomielite Inativada (VIP) + 1 (um) dos esquemas abaixo: a) 1 dose DTP + 1 dose Hepatite B + 1 dose <i>haemophilus b</i> ; ou b) 1 dose Tetravalente + 1 dose hepatite B; ou c) 1 dose Hexavalente.
Segundo Cenário	1ª dose de Pentavalente + 1 dose de Poliomielite Inativada (VIP) + 1 (um) dos esquemas abaixo: a) 2 doses DTP + 2 doses Hepatite B + 2 doses <i>haemophilus b</i> ; ou b) 2 doses Tetravalente + 2 doses hepatite B; ou c) 1 dose Tetravalente + 1 dose de DTP + 2 doses Hepatite B + 1 dose <i>haemophilus b</i> ; ou d) 2 doses de Hexavalente.
Terceiro Cenário	Nenhuma dose de Pentavalente + 1 (um) dos esquemas abaixo: a) 3 doses da Tetravalente + 3 doses da hepatite B; ou b) 3 doses DTP + 3 doses Hepatite B + 3 doses <i>haemophilus b</i>

Passo 01: Acessar ambiente “Sala de Imunização Informatizada”

(ACESSO-1) - Iniciar uma Sessão de Trabalho

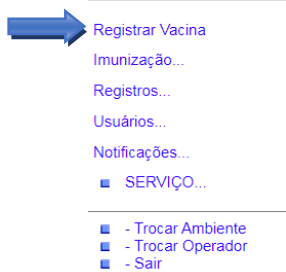
Você está autorizado a operar os seguintes Ambientes do Sistema:



Passo 02: Clicar em “Registrar Vacina” → Pesquisar Usuário ou matrícula

OLOSTECH

(SVE20413-0) - Registro Imunização



Recepções em aberto

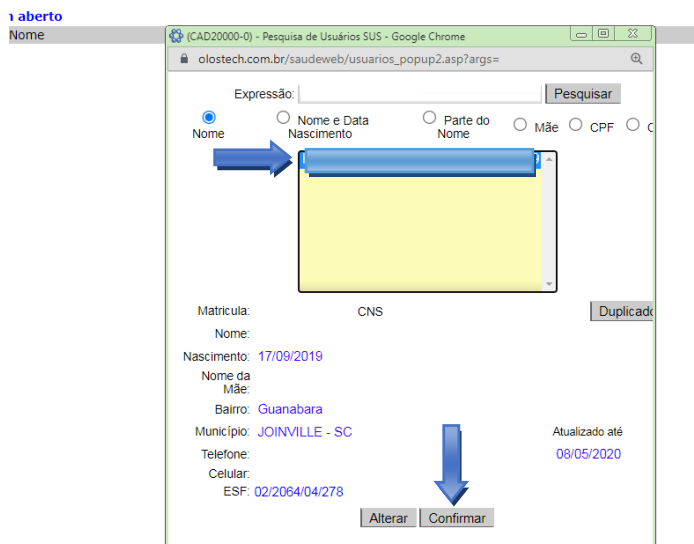
Hora	Nome	Idade	Profissional Procurado
------	------	-------	------------------------

Não há Pacientes aguardando no momento

Matrícula: ... +

Continuar

Passo 03: Localizar Usuário → Clicar em confirmar



Passo 04: Selecionar Vacinador → Selecionar Imunobiológico → Selecionar Estratégia → Selecionar via de administração → Selecionar local de aplicação → Selecionar dose → Aprazar (se necessário) → Clicar em Registrar

The screenshot shows a web-based form for vaccine registration. At the top, there is a text area for 'Observações' and a 'Gravar' button. Below this, the 'Data' is set to 02/01/2023. The 'Vacinador' field is a dropdown menu with 'Selecione...' and a blue arrow pointing to it. The 'Grupo' is set to 'População geral' and the 'Hora' is 14:50:45. The main section is titled 'Registro de Aplicação de Imunobiológico'. It contains several dropdown menus: 'Imunobiológico:' (Selecione...), 'Estratégia:' (Selecione um Imunobiológico...), 'Via de Administração:' (Selecione um Imunobiológico...), 'Local de Aplicação:' (Selecione uma Via de Administração...), and 'Dose:' (Selecione um Imunobiológico e uma Estratégia...). There is also a checkbox for 'Aprazamento:' with 'Não Aprazar' selected, and a 'Unidade de Aprazamento:' dropdown. At the bottom, there are checkboxes for 'Gestante:', 'Puérpera:', and 'Viajante:'. A 'Registrar' button is at the bottom right, with a blue arrow pointing to it. A 'Lote' button is also visible on the right side of the main form area.

INDICADOR 6 – Proporção de pessoas com hipertensão arterial, com consulta e pressão arterial aferida no semestre.

Recomendações específicas para o Indicador 6:

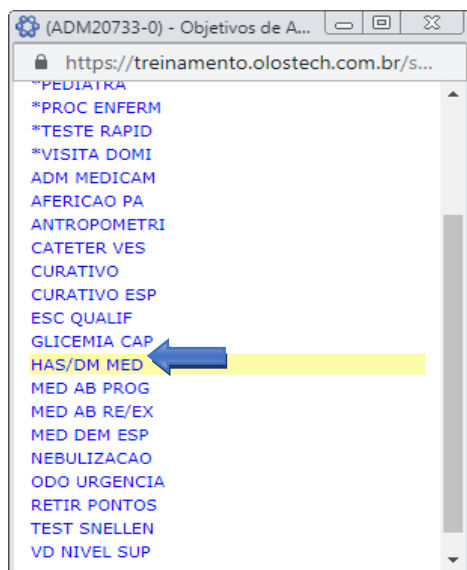
- ✓ Pessoas devem ser identificadas no mínimo um Atendimento individual (consulta) realizado por médico ou enfermeiro para condição hipertensão arterial nos últimos 6 meses + 1 aferição de pressão arterial realizada por médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem nos últimos 6 meses;
- ✓ Registrar com o código de procedimento da Tabela SIGTAP: 03.01.10.003-9 (aferição de pressão arterial) na aba “Pré - Consulta/Aferições”;
- ✓ Meta pactuada para este indicador é de 50%.

Importante: As Classificações CID-10/CIAP-2 consideradas no Indicador, bem como o campo rápido de condição avaliada “Hipertensão Arterial” no modelo de informação de atendimento individual devem ser preenchidos apenas se o indivíduo possuir o diagnóstico da doença.

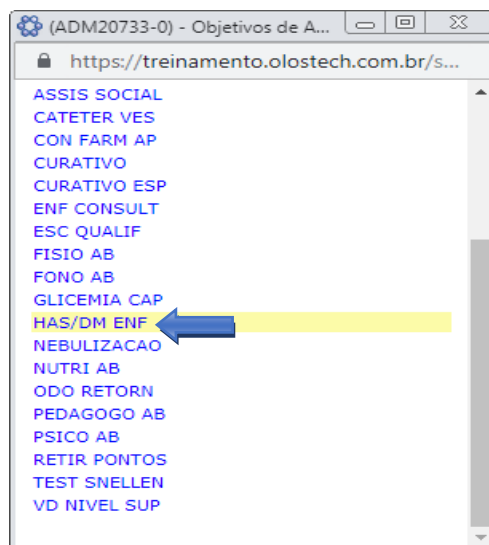
Para este dado **NÃO** há possibilidade de correção.

Passo 01: Recepcionar o usuário utilizando o objetivo HAS/DM enf (enfermeiros) ou HAS/DM med (médico)

Médicos



Enfermeiros



Passo 02: Registrar os dados da pré-consulta (caso o usuário não tenha passado por uma triagem anterior)

Pré-Consulta/Aferições

Pré-Consulta não Realizada

Realiza Pré-Cons

Ocorrências em Saúde

Avaliação/Resultados

Cons. Alimentar

Atendimento Compartilhado

Dados Clínicos Permanentes

Clique para Editar

Índices/Gráficos	Perímetro Cefálico	Peso/Altura	Peso/Idade	Altura/Idade	IMC/Idade	IMC entre 20 anos e 60 anos	Glicemia	P.A.
	0 a 5 anos	0 a 2 anos	0 a 5 anos	0 a 5 anos	0 a 5 anos	IMC	Glicemia	P.A.

Evolução

Clique para Editar

Evolução Confidencial

Clique para Editar

Procedimentos

CID10

Passo 03: Preencher a informação de “pressão” → gravar

Ocorrências em Saúde

Resultados de exames

Dados Históricos

Aferições

Peso* 0,000 Kg

Estatuta* 0,0 cm

Pressão 180 / 120 mmHg

Circunferência Abdominal cm

Temperatura °C

Frequência Cardíaca bpm

Nível de Glicemia mg/dl Tipo de Glicemia Seleccione...

Perímetro Cefálico cm

Vacinação em Dia* Sim, vacina em dia Caderneta

Condição (Informe dados importantes p/ conhecimento do Médico.)

Informações

Atenção! Campos marcados com asteriscos (*) em azul serão transmitidos para o E-SUS.

Gravar Fechar

Passo 04: Registrar o CID-10 (médicos) e o CIAP-2 (enfermeiros)

Pré-Consulta/Aferições

Profissional: **Denis Albino De Oliveira**

Peso (Kg): Estatura (cm): Temperatura: Pressão Arterial: **180/120** Hora: **18:23**

Glicemia(mg/Dl): Tipo de Glicemia: Circunferência Abdominal (cm): Frequência Cardíaca: Perímetro Cefálico (cm): Condição:

Vacinação em Dia: **Sim, vacina em dia**

[Ocorrências em Saúde](#) [Avaliação/Resultados](#) [Cons. Alimentar](#)

Atendimento Compartilhado

Dados Clínicos Permanentes

[Clique para Editar](#)

Índices/Gráficos

Perímetro Cefálico	Curvas de Crescimento				IMC entre 20 anos e 60 anos	Glicemia	P.A.
	Peso/Altura	Peso/Idade	Altura/Idade	IMC/Idade			
0 a 5 anos	0 a 2 anos	0 a 5 anos	0 a 5 anos	0 a 5 anos	IMC	Glicemia	P.A.
2 a 5 anos	5 a 10 anos	5 a 19 anos	5 a 19 anos	5 a 19 anos			

Evolução

[Clique para Editar](#)

Evolução Confidencial

[Clique para Editar](#)

Procedimentos

0301010064 - Consulta Medica Em Atencao Basica

Hipótese Diagnóstica

CID10 **Não informado** **Notificação**

Quadro 05 – Classificação CID-10/CIAP-2 para Doenças Hipertensivas

Profissional	CID-10/CIAP-2	Descrição
Médico	- I10; - I11, I11.0, I11.9; - I12, I12.0, I12.9; - I13, I13.0, I13.1, I13.2, I13.9; - I15, I15.0, I15.1, I15.2, I15.8, I15.9; - I27.0, I27.2;	Hipertensão essencial (primária); Doença cardíaca hipertensiva; Doença renal hipertensiva; Doença cardíaca e renal hipertensiva; Hipertensão secundária; Doença cardíaca pulmonar e da circulação pulmonar;
	O10, O10.0, O10.1, O10.2, O10.3, O10.4, O10.9	Hipertensão preexistente complicando a gravidez, o parto e o puerpério.
Enfermeiro	- K86; - K87; - W81	Hipertensão sem complicações; Hipertensão com complicações; Toxemia gravídica / DHEG

Fonte: Classificação Internacional de Atenção Primária – Segunda Edição (CIAP-2), Classificação Internacional de Doenças (CID-10)

Passo 05: Selecionar o problema/condição avaliada HIPERTENSÃO ARTERIAL

Procedimentos

0301010064 - Consulta Medica Em Atencao Basica

Hipótese Diagnóstica

Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP)

Problema/Condição Avaliada

☐ PRE-NATAL
☐ SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA
☒ **HIPERTENSÃO ARTERIAL**
☐ OBESIDADE
☐ ASMA
☐ TABAGISMO
☐ USUARIO DE OUTRAS DROGAS
☐ REABILITACAO

☐ PUERPERIO (ATE 42 DIAS)
☐ PUERICULTURA
☐ DIABETES
☐ DESNUTRICAO
☐ USUARIO DE ALCOOL
☐ SAUDE MENTAL

Doenças Transmissíveis
☐ TUBERCULOSE
☐ HANSENIASE
☐ DENGUE
☐ DST

Rastreamento
☐ CANCER DE MAMA
☐ RISCO CARDIOVASCULAR

Tipo de Atendimento: **Selecione...** Origem da consulta: **Recepcionado**

Local de Atendimento: **01 - Ubs**

Atenção Domiciliar: **Selecione...**

Racionalidade em saúde: **Selecione...**



INDICADOR 7 – Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.

Recomendações específicas para o Indicador 7:

- ✓ Solicitação do exame de hemoglobina glicada registrado com o código SIGTAP: 02.02.01.050-3 (Dosagem de Hemoglobina Glicosilada). Esta solicitação deverá ter ocorrido no prazo de 6 meses a contar do último mês do quadrimestre, e pode ocorrer em momentos distintos da consulta.
- ✓ A meta pactuada para este indicador é de 50%.

Importante: Os CIDs e CIAPs considerados neste Indicador correspondem a condições crônicas de Diabetes Melittus (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), estes contabilizados no denominador. Condições transitórias ou agudas de elevação dos níveis glicêmicos ou elevação da Pressão Arterial (PA), utilizar CIDs que **NÃO Contabilizam no Indicador**:

- R73 – Aumento da glicemia;
- R73.9 – Hiperglicemia não especificada;
- O24 – Diabetes Melittus na Gravidez;
- R03 – Valor anormal da pressão arterial.

Passo 01: Recepcionar a paciente utilizando o objetivo HAS/DM enf (enfermeiros) ou HAS/DM med (médico)

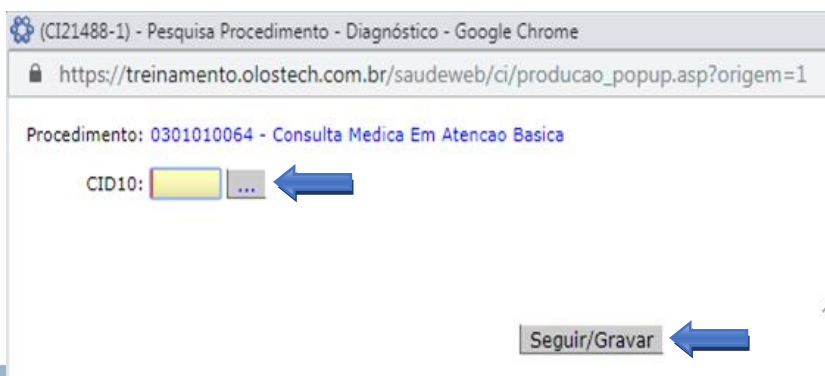
Médicos



Enfermeiros



Passo 02: Registrar o CID → Gravar



Quadro 06 – Classificação CID-10/CIAP-2 para Diabetes Mellitus

Profissional	CID-10/CIAP-2	Descrição
Médico	E10.0, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, E10.5, E10.6, E10.7, E10.8, E10.9;	Diabetes Mellitus
	E11, E11.0, E11.1, E11.2, E11.3, E11.4, E11.5, E11.6, E11.7, E11.8, E11.9;	
	E12, E12.0, E12.1, E12.2, E12.3, E12.4, E12.5, E12.6, E12.7, E12.8, E12.9;	
	E13, E13.0, E13.1, E13.2, E13.3, E13.4, E13.5, E13.6, E13.7, E13.8, E13.9;	
	E14, E14.0, E14.1, E14.2, E14.3, E14.4, E14.5, E14.6, E14.7, E14.8, E14.9;	
	O24, O24.0, O24.1, O24.2, O24.3, O24.4, O24.9;	Diabetes mellitus na gravidez
Enfermeiro	T89; T90	Diabetes insulino-dependente; Diabetes não insulino-dependente

Fonte: Classificação Internacional de Atenção Primária – Segunda Edição (CIAP-2), Classificação Internacional de Doenças (CID-10)

Passo 03: Conferir as informações preenchidas → CID-10/CIAP-2 → Problema/condição avaliada

Procedimentos CID10 ? +

0301010030 - Consulta De Profissionais De Nivel Superior Na Atencao Basica (Exceto Medico) -

Hipótese Diagnóstica Notificação ? +

Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP) ? +

T89 - DIABETES INSULINO-DEPENDENTE ←

Problema/Condição Avaliada ?

☐ PRE-NATAL
☐ SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA
☐ HIPERTENSAO ARTERIAL
☐ OBESIDADE
☐ ASMA
☐ TABAGISMO
☐ USUARIO DE OUTRAS DROGAS
☐ REABILITACAO

☐ PUERPERIO (ATE 42 DIAS)
☐ PUERICULTURA
☒ **DIABETES** ←
☐ DESNUTRICAO
☐ DPOC
☐ USUARIO DE ALCOOL
☐ SAUDE MENTAL

Doenças Transmissíveis
☐ TUBERCULOSE
☐ HANSENIASE
☐ DENGUE
☐ DST

Rastreamento
☐ CANCER DE MAMA
☐ RISCO CARDIOVASCULAR

Tipo de Atendimento: 1 - Consulta agendada programada / cuidado continuado Orç consulta: Recepcionado ?

Local de Atendimento: 01 - Ubs ?

Atenção Domiciliar: Selecione... ?

Racionalidade em saúde: Selecione... ?

Passo 04: Solicitar e agendar o procedimento: 99000536 – hemoglobina glicosilada, dosagem de (PMV)

Procedimentos

Modo de Pesquisa: ☒ Procedimento ☐ Cesta de Exames

Pesquisar Procedimento: hemoglobina

Grupo de Controle: Exames laboratoriais - Geral (Listar todos os procedimentos do Grupo de Controle)

Procedimentos Disponíveis para Seleção

★ 99000536 - Hemoglobina Glicosilada, Dosagem De (PMV) ←

Procedimentos Selecionados DUP

99000536 - Hemoglobina Glicosilada, Dosagem De (PMV)

Passo 05: Em caso de resultado de hemoglobina glicosilada clicar em avaliação/resultados para fazer o referido lançamento

Procedimentos

pesquisar procedimento: ☐ Buscar procedimentos ☒ **Requisições** ☐ Procedimentos do atendimento ☐ Favoritos

Filtro de requisições: ☒ Todos profissionais ☐ Minhas requisições ☐ Nr. requisição

Procedimentos Disponíveis para Seleção

Nº	Profissional	Data
Req. 4374517	F	31/03/2022
Req. 4374582	Fátima Mucha - Pediatra	31/03/2022
Req. 3426596	Fátima Mucha - Pediatra	13/08/2021
Req. 2730570	Maria Simone Pan - Médico(a) da ESF	22/02/2021

Procedimentos Selecionados

Código	Descrição
É necessário selecionar ao menos um procedimento!	

Informações

Data de Referência: 11/04/2022

Identificador:

Visibilidade:

Descrição:

Procedimentos

pesquisar procedimento: ☐ Buscar procedimentos ☒ **Requisições** ☐ Procedimentos do atendimento ☐ Favoritos

Filtro de requisições: ☒ Todos profissionais ☐ Minhas requisições ☐ Nr. requisição

Procedimentos Disponíveis para Seleção

Nº	Profissional	Data	Ação
Req. 4374517	Fátima Mucha - Pediatra	31/03/2022	☐
Req. 4374582	0202050322 - Somatostatina C (Igf1), Dosagem De	31/03/2022	☐
	Fátima Mucha - Pediatra		☐
	0202030150 - Imunoglobulina A (Iga), Dosagem De		☐
	99000234 - Anticorpos Antitransglutaminase Recombinante Humano Iga, Dosagem De (PMV)		☐
	99000038 - Creatinina, Dosagem De - SANGLIE (PMV)		☐

Procedimentos Selecionados

Código	Descrição	Ação
99000217	Ovos E Cistos De Parasitas, Pesquisa De (Parasitológico fezes) (PMV)	☒
99000542	Ferritina, Dosagem De (PMV)	☒
99000214	Hemograma Completo (PMV)	☒
0202030154	Imunoglobulina E (Ige), Dosagem De	☒

Informações

Data de Referência: 11/04/2022

Número da Requisição: 2730570

Visibilidade:

Alterado 216.3 mg/dl

Descrição:

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. DataSUS. **Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**. Brasília – DF: 2023.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 102, de 20 de janeiro de 2022**. Altera a Portaria GM/MS nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho, no âmbito do Programa Previne Brasil. Brasília – DF: 2022.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Imunizações (PNI). **Calendário Nacional de Vacinação**. Brasília – DF: 2022.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019**. Dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho, no âmbito do Programa Previne Brasil. Brasília – DF: 2019.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019**. Institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. Brasília – DF: 2019.
6. JOINVILLE. Secretaria da Saúde. Diretoria de Políticas de Saúde. Gerência de Gestão Estratégica e Articulação da Rede em Saúde. Planejamento. **Plano Municipal de Saúde 2022-2025**. Joinville – SC: 2022.
7. Organização Mundial da Saúde. Organização Panamericana da Saúde. **Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionadas à Saúde**, décima revisão (CID-10). 8ª edição. São Paulo – SP: 2000.
8. World Organization of National Colleges, Academies, and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA). **Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP-2)**. Elaborada pelo Comitê Internacional de Classificação da WONCA (Associações Nacionais, Academias e Associações Acadêmicas de Clínicos Gerais/Médicos de Família. Consultoria, supervisão e revisão técnica desta edição, Gustavo Diniz Ferreira Gusso. 2ª edição. Florianópolis – SC: Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, 2009.